MOGAD诊断与治疗

2025 · 正面

识别与确诊框架

急性痛性视力下降、双眼同时受累、视盘水肿时考虑MOG相关视神经炎。确诊须核心事件+符合MOG-IgG条件+排除其他病；不能仅凭抗体阳性。

2025 p705–706、711

抗体阈值与附加条件

CBA≥1：100为明确阳性；≥1：10且<1：100为弱阳性。弱阳性、滴度未知或仅脑脊液阳性，另需AQP4阴性+≥1附加条件（完整标准见提取表）。

2025 p710–711

视神经炎附加条件

双侧同时受累、病灶>50%视神经长度、视盘水肿、视神经周围强化，任一可作对应支持条件；仍须核心事件、抗体条件及排除其他病。

2025 p711

送检与影像

优先血清live-CBA，尽量治疗前取样；治疗后阴性者≥3个月后或复发时复测。眼眶MRI含T1/T2、脂肪抑制及增强，层厚2~3 mm。

2025 p706、710–711

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转

MOGAD诊断与治疗

2025 · 背面

急性激素与缓减

成人IVMP 1 000 mg/d×3~5 d；儿童20~30 mg·kg⁻¹·d⁻¹。之后递减、转口服激素，口服减量过程≥6个月；完整递减阶梯见提取表。

2025 p712

重症/激素反应差

可联合IVIG 0.4 g·kg⁻¹·d⁻¹×5 d；激素反应差可血浆置换5~7次，每次1.0~1.5倍血浆容量。危重者可同步启动；避免IVIG后立即置换。

2025 p712

何时启动序贯治疗

首次严重且恢复差（如EDSS仍≥2分、视力仍<0.6），或发作≥2次，可考虑序贯治疗。可选硫唑嘌呤、MMF、RTX、托珠单抗或间歇IVIG；方案见提取表。

2025 p714–715

监测、备孕与停药

按药物筛查感染并监测血常规、肝/肾功能。MMF备孕前≥6周停药。一般认为持续治疗满5年且无复发，可个体评估是否停药，勿自动停药；固定随访间隔、孕产哺乳完整方案原文未明确。

2025 p708、712、714–715

临床要点摘要；完整条件与原文缺项见提取表。
100%原尺寸 · 双面长边翻转